HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E
Crecemos para cuidar tu Salud!

CONEXIÓN CLÍNICA
Crecemos en Saber

FALLA CARDIACA *Crónica*

1 ¿EN QUIÉN SOSPECHAR?

1. Paciente con factores de riesgo cardiovascular o antecedente de cardiopatía estructural, que cursa con signos y/o síntomas sugestivos de la enfermedad.

Síntomas	Signos
Típicos • Disnea | Ortopnea • Disnea paroxística nocturna • Tolerancia disminuida al ejercicio • Fatiga |cansancio • >> Tiempo para recuperarse del ejercicio • Inflamación de tobillos	Más específicos • Presión venosa yugular elevada • Reflujo hepatoyugular • Tercer sonido cardiaco (ritmo galopante) • Impulso apical desplazado lateralmente
Menos típicos • Tos nocturna • Sibilancias • Sensación de hinchazón • Pérdida de apetito • Confusión (especialmente en ancianos) • Depresión • Palpitaciones • Mareo | Síncope • Bendopnea	Menos específicos • Aumento de peso (> 2 kg/semana) • Pérdida de peso (IC avanzada) • Pérdida de tejido (caquexia) • Soplo cardiaco • Edema periférico (tobillos, sacro, escroto) • Crepitantes pulmonares | Derrame pleural • Taquicardia | Pulso irregular | Taquipnea • Respiración de Cheyne-Stokes • Hepatomegalia | Ascitis • Extremidades frías • Oliguria | Presión de pulso estrecha

FACTORES DE RIESGO

Enfermedad coronaria, HTA, ERC, DM, valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, cardiopatías congénitas, infecciones (Chagas, Lyme, virales), Infiltrativas, enfermedad pericárdica / endomiocárdica (radioterapia, síndrome carcinoide, fibrosis, calcificaciones), alteraciones metabólicas, enfermedad neuromuscular

Tomado y adaptado de:
McDonagh TA et al., 2021 (ESC Heart Failure Guidelines).
McDonagh TA et al., 2023 (ESC Focused Update).

2 SOLICITAR PARACLÍNICOS

Química
- Hemograma
- Creatinina
- Función tiroidea
- Electrolitos
- Glucosa en ayunas
- Hb1AC
- Perfil lipídico
- Perfil ferropénico

** *Buscar etiología***

Rx Tórax
Descartar etiología pulmonar, evidencia de cardiomegalia, signos de congestión pulmonar

EKG
Trastornos del ritmo, alteración de la conducción, hipertrofia auricular/ventricular.

Péptidos Natriuréticos
NT- PROBNP ⩾ 125 pg/ml
BNP ⩾ 35 pg/ml

3 SOLICITAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Hallazgos

ANOMALIA ESTRUCTURAL
- Dilatación de cavidades, hipertrofia ventricular, alteraciones valvulares, aumento de presiones

ANOMALIA FUNCIONAL
- Disfunción sistólica y/o diastólica del ventriculo izquierdo (Hipocinesia, acinesia o discinesia)

EVALUAR LA FEVI

4 INICIAR TRATAMIENTO SEGUN FEVI

FEVI REDUCIDA ≤ 40%

- IECA/ ARNI
- Betabloqueador
- ARM
- iSGLT2
- Diuretico de asa: retención de fluidos

DERIVAR A CARDIOLOGIA

FEVI ⩽ 35% Y QRS <130 S y cuando sea apropiado
DAI
-Isquemica Clase I
-No isquemica Clase IIa

FEVI > 35% o el manejo con dispositivos no está indicado | inapropiado
Considere uso de medicamentos clase II: hidralazina, dinitrato de isosorbida, ivabradina, vericiguat, digoxina
** *Información en GPC ESC Falla cardiaca 2021***

Ritmo sinusal y FEVI ⩽35% Y QRS ⩾ 130 ms
TRC-D: QRS 130-149 ms
MP: QRS ⩾ 150 ms

FEVI LIGERAMENTE REDUCIDA 41-49%

A TODOS LOS PACIENTES: DIURETICOS PARA ALIVIAR SINTOMAS Y SIGNOS

Para reducir riesgo de hospitalización y muerte considerar uso de:
- IECA/ ARA II; ARM; Betabloqueador.
- ARNI: No evidencia clara. considerar uso en sintomáticos u hospitalizaciones

DERIVAR A MEDICINA INTERNA / FAMILIAR

FEVI CONSERVADA ≥ 50%

BASE DE TRATAMIENTO: Control de comorbilidades: HTA, DM2, ERC, FA, Obesidad, Cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular
- **Diuréticos:** reducen congestión, síntomas y riesgo de hospitalización. Se usan hasta que se logre euvolemia. Primera línea → diuréticos de ASA. En HTA uso de tiazídicos /ARM es buena opción.
- **iSGLT2:** reduce muerte por causas CV y hospitalizaciones
- **GLP-1:** en pacientes con obesidad asociada: reduce la inflamación, mejora la tolerancia al ejercicio, reduce peso de forma significativa, mejora calidad de vida

DERIVAR A MEDICINA FAMILIAR

RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO AMBULATORIO
****ALGORITMO FALLA CARDIACA AGUDA****
DERIVAR A EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO - COMORBILIDADES

DOSIS DE FÁRMACOS A RECORDAR

IECA/ARA II	ARNI	ARM	iSGLT2	OTROS
Captopril 6.25- 50 mg / 8h Enalapril 2.5 - 20 mg/12h Losartán 50 mg/24h Candesartan 4-32 mg/24h Valsartán 40-160 mg/12h	Sacubitril valsartán 49 - 51 hasta 97-103 mg/12h	Espironolactona 25-50 mg /24h Eplerenona 25-50 mg/24h	Dapagliflozina 10 mg/24h Empagliflozina 10 mg/24h	Ivabradina 5-7.5 mg/12h Vericiguat 2.5-10 mg/24h Digoxina 62.5 mcg/24h Hidralazina+dinitrato isosorbida: 37.5 + 20 hasta 75 +40 mg/8h